

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	心律不整 Arrhythmia				
編號	A31000-Q03-W-B01	制定者	CCU 林炳蓁	公布日期	97 年 05 月 31 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	114 年 10 月 08 日
版本/總頁數	第 3.8 版/7 頁	審查者	曾翊鍵	檢閱日期	114 年 10 月 08 日

一、目的

讓護理人員了解心律不整的定義、症狀、常見檢查、常見治療、護理問題與護理措施及衛教指導，有更適切之照護能力，提供最佳服務品質。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）定義

心律不整(arrhythmia)亦稱節律異常(dysrhythmia)。是由於心臟內電氣衝動的起跳或傳導障礙而引起血液動力學方面的改變，造成不正常的心跳或節律。

（二）症狀

當心律不整造成心輸出量減少時，病人會出現虛弱、不安、胸痛、暈眩及尿量減少等症狀，心博過速者會感到心悸或胸部跳動感，其他可能出現的症狀包括：血壓降低、皮膚蒼白、冰冷、心尖脈或末梢脈搏的速率間有差距、喪失定向感，以及意識混亂。

（三）常見檢查

1. 心電圖(Electrocardiogram, ECG)。
2. 霍爾特心電圖監視器(Holter EKG)：持續性的紀錄 24 小時心電圖變化，以偵測出現症狀時之心電圖，協助醫師診斷。
3. 電氣生理檢查(Electrophysiologic study, EPS)：電氣導管異於一般心導管，為直徑約 3-4mm 的實心導管。通常由股靜脈進入，透過螢幕監視，緩緩將電極導管置

主題名稱	心律不整	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-B01	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	2/7

入心臟腔室內，記錄心臟傳導變化，用以測試心電圖傳導系統。

4. 實驗室值：電解質、血中藥物濃度。

（四）常見治療

主要治療方式為藥物治療、裝置心律節律器、矯正或緩解心律不整的根本原因，例如：供給氧氣、調節電解質之平衡（尤其是鉀離子）、心衰竭之治療、減輕焦慮、移除有害的刺激。抗心律不整藥物治療根據其作用分為四大類：

1. 鈉離子通道阻斷劑：如 Quinidine、Procainamide、Lidocaine；常用在心室不整脈。
2. β 阻斷劑如：Propranolol、Atenolol，來抑制心室的去極化，延長房室傳導，降低心跳速率與心肌收縮。
3. 鉀離子通道阻斷劑：延長動作電位閥興奮藥物，如 Amiodarone、Bretylium，用於致死之心律不整脈、心房撲動、心房顫動。
4. 鈣離子通道阻斷劑：減緩第四期之自發性去極化，如 Verapamil。

（五）護理問題

1. 疼痛不適／與裝置心臟節律器有關有關。
2. 活動耐力不足／與氧氣供需失衡有關。
3. 尋求健康協助／與急性疾病、生活方式的明顯改變或（和）部分身體的失控有關。
4. 低心輸出量／與心律不整有關。
5. 低心輸出量／與左心室或右心室功能不全有關。

（六）護理措施

1. 疼痛不適／與裝置心臟節律器有關。
 - (1)評估病人的疼痛指數及特徵。
 - (2)減少或排除疼痛的因素、加劇的原因。
 - (3)教導深呼吸、背部按摩、冥想等放鬆技巧。
 - (4)提供音樂、書籍轉移注意力。

主題名稱	心律不整	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-B01	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	3/7

(5)在病人選擇疼痛控制方法時，給予支持與指導。

(6)依醫囑給予嗎啡類止痛劑。

(7)評估藥物的效果及副作用。

2. 活動耐力不足／與氧氣供需失衡有關。

(1)活動前、後測量生命徵象，並監測心電圖之改變。

(2)與病人討論調整活動的必要性以減少心臟工作負荷的要求，並發展個別化及漸進式的活動。

(3)衛教病人應按時服用藥物，可促進活動的耐力。

(4)協助病人採半坐姿或坐姿，並給予氧氣使用。

(5)向病人或家屬說明活動耐受力之影響因子。

(6)教導學習或練習鬆弛技巧以避免促使活動無耐力的情形。

(7)教導病人心臟代償的警訊。

(8)教導當引起病人有疼痛或疲累情形時，便應終止或減少活動。

(9)教導病人或家屬省力的方法，避免等長運動、槓桿原理。

(10)教導病人監測自己對活動的生理反應，有助於評估日常生活活動度。

(11)判斷病人或配偶是否有性諮商的需要，適時給予資訊。

3. 尋求健康協助／與急性疾病、生活方式的明顯改變或（和）部分身體的失控有關。

(1)予以簡單的用詞向病人解釋不同監視器和治療儀器的使用之目的及方法，以減輕疑惑而引起的焦慮。

(2)必要時依醫囑給予鎮靜劑。

(3)必要時給予衛教手冊，以供參考。

4. 低心輸出量／與心律不整有關。

(1)注意呼吸速率和節律。

(2)裝置生理監視器監測生命徵象、意識型態、心跳速率和節律。

(3)評估皮膚溫度和顏色，及觀察周邊水腫，每日固定時間量體重並記錄。

主題名稱	心律不整	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-B01	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	4/7

(4)監測血液電解值濃度。

(5)教導病人正確的記錄輸出入量。

(6)給予氧氣並記錄使用效果。

(7)依醫囑給予抗心律不整或增加心輸出量之藥物。

(8)必要時協助醫師即時給予適當的治療，如裝心律調節器等。

5. 低心輸出量／與左心室或右心室功能不全有關。

(1)注意呼吸速率和節律，給予氧氣並記錄使用效果。

(2)監測生命徵象及意識型態。

(3)裝置生理監視器監測心跳速率和節律。

(4)評估皮膚溫度和顏色，觀察周邊水腫，每日量體重並記錄。

(5)依醫囑給予藥物並記錄使用效果。

(6)依醫囑控制液體攝入量。

(7)教導病人減少熱量的消耗。

(七) 衛教指導

1.服用毛地黃藥物的衛教：應注意血壓之變化及注意有無腹瀉、心跳過緩、黃疸、嘔吐等毛地黃中毒症狀出現。

2.服用 β 阻斷劑藥物衛教：不可突然停藥，因會導致心肌缺氧。

3.服用 Amiodarone 會引起肺間質纖維化；服用 Bretylium 要注意姿勢性低血壓的發生。

4.教導病人正確的記錄輸出入量。

(八) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(略)

主題名稱	心律不整	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-B01	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	5/7

五、流程圖

(略)

六、參考資料

- (一) 蔡秀鸞、吳淑鈴、吳宏蘭、李瑜弘、黃嫦芳等(2019)・重症護理學-重症單位常用的藥物・台北：永大。
- (二) 林嘉慧、楊順在 (2022)・心房顫動引起心律不整院前救護與院內處置經驗分享・醫療救護與緊急應變，66-67。
- (三) 李修銓 (2023)・胸悶、心悸頻發好困擾，電燒術助擺脫心律不整・健康世界，(558)，19-20。
- (四) 健康世界編輯部 (2022)・中華民國心律醫學會呼籲小心無預警的心律不整猝死・健康世界，(549)，14-15。

七、附件

(略)

主題名稱	心律不整	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-B01	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	6/7

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
97.05.31	1.0	新制定	97 年 05 月 31 日護理部照護標準委員會通過
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版	
100.08.31	2.1	修改主題名稱英文與錯別字	100 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
101.08.31	2.2	1.內容審閱修正 2.醫護部改護理部	101 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
102.02.08	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱	
102.08.31	3.1	說明內容部分修辭	102 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
103.06.30	3.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
104.02.03	3.2	更新第六項參考資料	104 年 02 月 03 日護理部照護標準委員會通過
105.08.31	3.3	1. 新增參考文獻資料於內文中。 2. 第六項參考資料增刪及修訂。	105 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
106.08.31	3.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.06.29	3.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.09.12	3.4	第二項新增（含中興分院）。	107 年 09 月 12 日護理長會議通過
108.09.23	3.5	第三項第八日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 09 月 11 日護理長會議通過;108 年 09 月 23 日督導會議通過公布。

主題名稱	心律不整	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-B01	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	7/7

修正日期	版本	修正說明	備註
109.08.18	3.6	第三項第五、六目說明內容文字修訂。	109 年 08 月 06 日照護標準組會議通過；109 年 08 月 12 日護理長會議通過；109 年 08 月 18 日督導會議通過公布。
110.08.05	3.6	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
111.09.06	3.7	1. 第三項第四目說明內容部份增刪。 2. 更新第三項第五、六目護理問題。 3. 第六項參考資料增刪。 4. 內文參考文獻引用刪除。	111 年 08 月 04 日照護標準組會議通過；111 年 08 月 10 日護理長會議通過；111 年 09 月 06 日督導會議通過公布。
112.08.03	3.7	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
113.08.08	3.7	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
114.10.08	3.8	1.第三項第五、六目：健康尋求行為修訂為尋求健康協助。 2.更新第六項參考資料。	114 年 08 月 07 日照護標準組會議通過；114 年 09 月 10 日護理長會議通過；114 年 10 月 08 日督導會議通過公布。